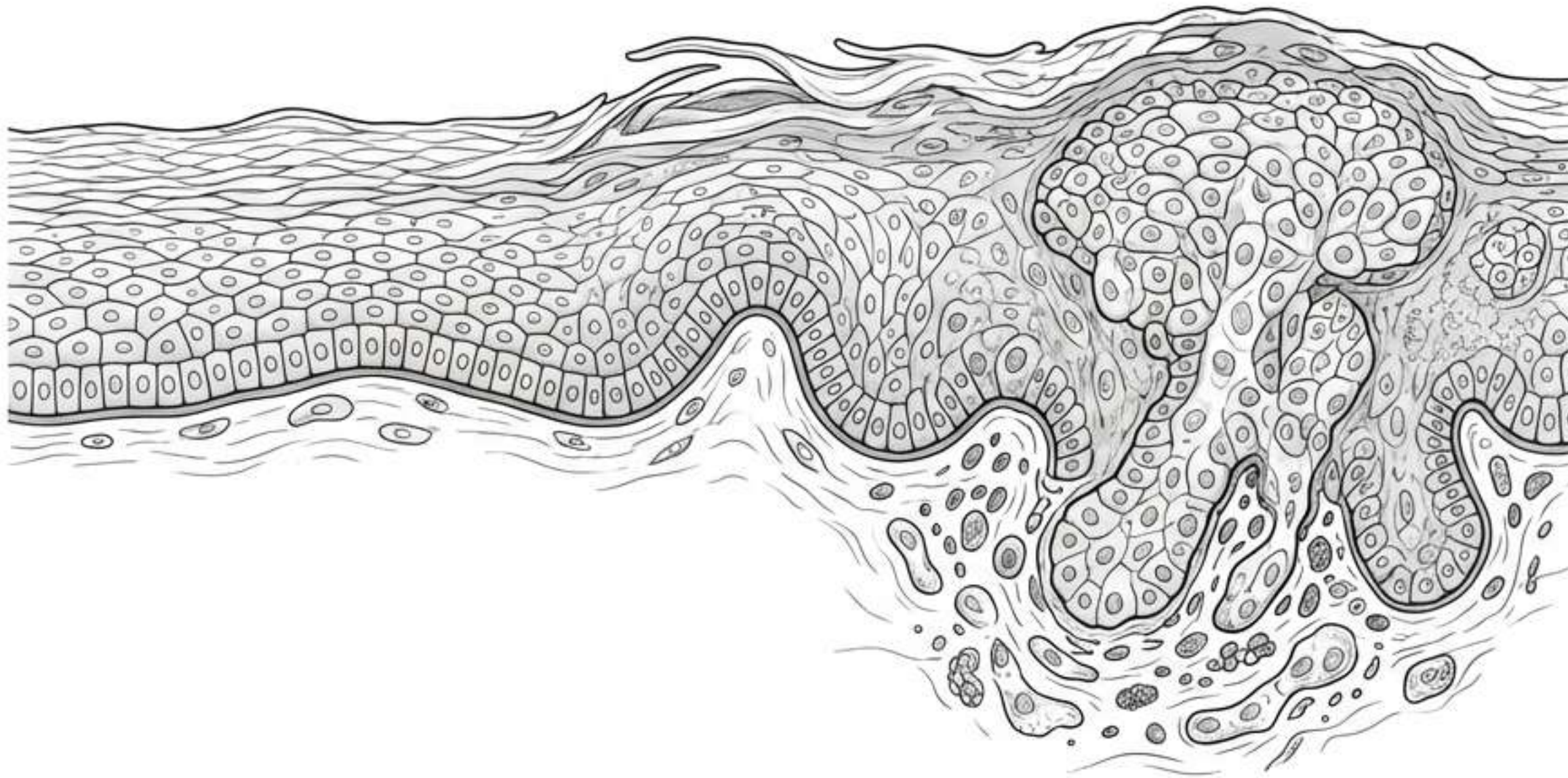


# Tumeurs Épithéliales : Guide d'Étude Complet

Du Papillome bénin au Carcinome infiltrant – Corrélations Anatomico-Cliniques



---

Basé sur le polycopié officiel & Analyse des EMDs (2019-2024)



# Analyse Stratégique des Examens (Pattern Analysis)

## Tableau des Concepts Clés

| Concept                 | Description                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Papillome (Bénin)       | Toujours épithélial. Jamais conjonctif.<br>Triade histologique indispensable. |
| Adénome                 | Risque de dégénérescence maligne (Carcinome).                                 |
| Carcinomes Épidermoïdes | Critères de maturité : Ponts d'union + Kératinisation.                        |
| Pronostic Vital         | Basocellulaire (Local) vs Spinocellulaire (Lymphophile).                      |

## Pièges & Fréquence

### ⚠ PIÈGES À ÉVITER :

- Ne pas confondre Adénocarcinome (Malin) et Adénome (Bénin).
- 'In Situ' = Membrane basale intacte = Bon pronostic.

## Radar des Fréquences





# 1. Tumeurs Bénignes des Épithéliums Malpighiens (Papillome)

**Clinique** : Lésions exophytiques, faisant saillie (cutané ou muqueux). Terme général : Papillome.

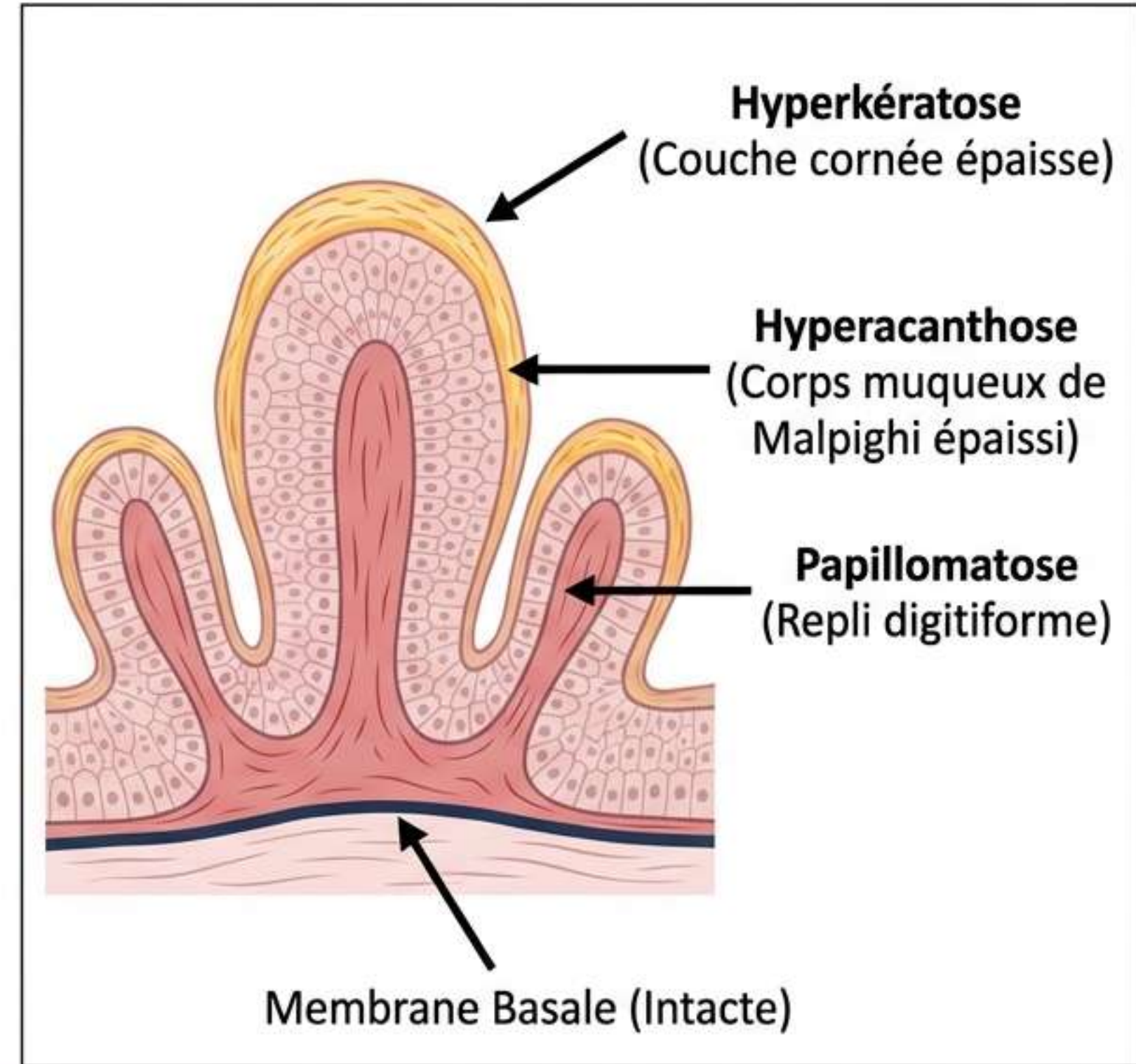
**La Triade Microscopique (À Retenir) :**

1. **Papillomatose** : Replis digitiformes de l'épithélium, centrés par un axe conjonctif étiré.
2. **Hyperacanthose** : Hyperplasie du corps muqueux de Malpighi (augmentation du nombre de cellules).
3. **Hyperkératose** : Épaississement de la couche cornée.

**Cytologie** : Aspect normal. Pas d'atypies, pas de mitoses anormales.

**Critère Absolu** : L'ensemble est limité par une membrane basale intacte. [Ref: Q5, Q8]

**Attention** : Une papillomatose est susceptible de donner naissance à des cancers épidermoïdes. [Predicted – Potential Pre-cancer]





# 1b. Tumeurs Bénignes des Épithéliums Glandulaires (Adénomes)

**Définition** : Tumeurs épithéliales glandulaires bénignes. [Ref: Q3]

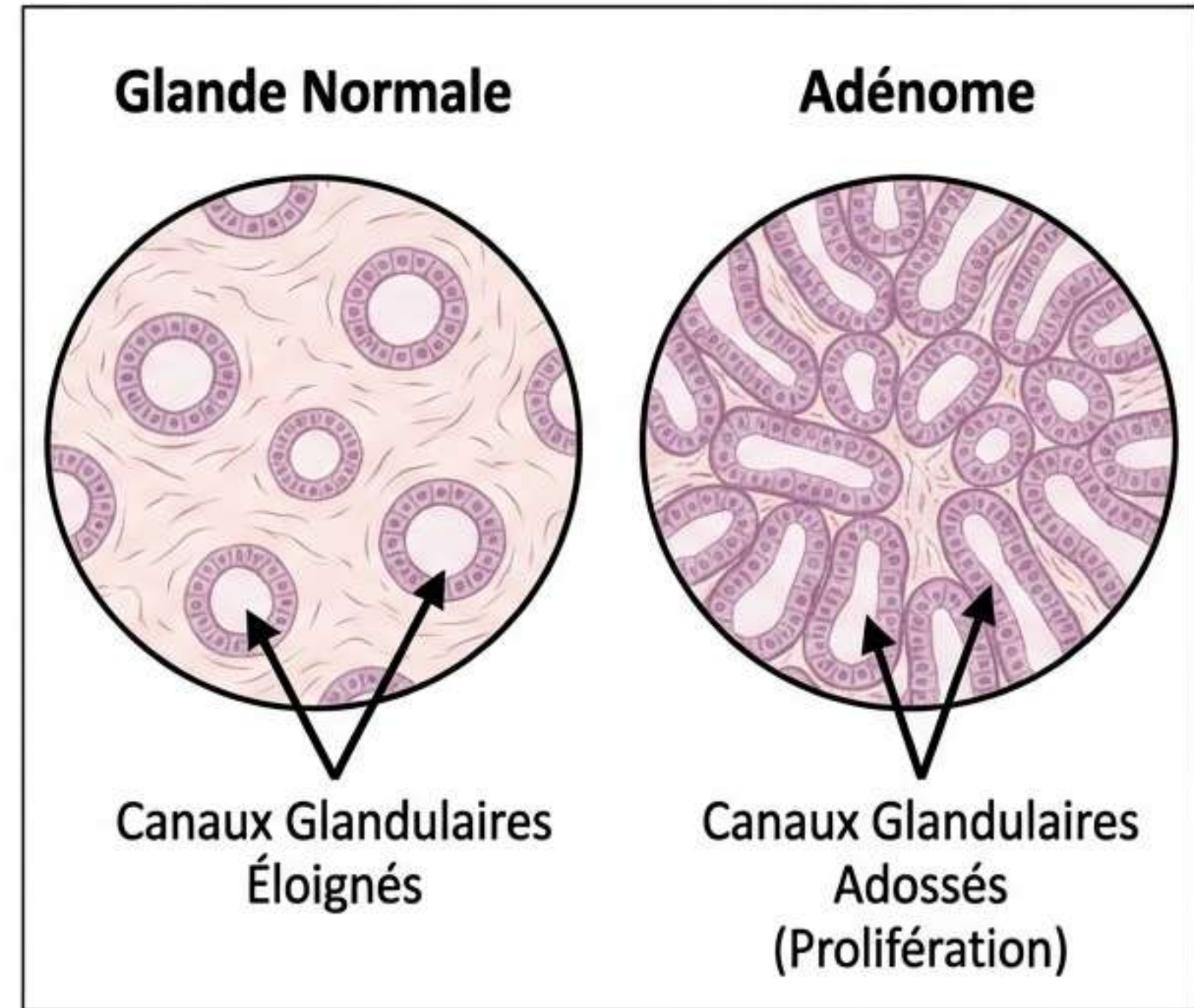
## Macroscopie :

- Lésions nodulaires.
- Unique ou multiples (Adénomatose).
- Siège : Glandes (ex: Parotide), Cavité buccale.

## Microscopie :

- Prolifération de glandes (nombre de cavités augmenté).
- Types histologiques : Tubuleux, vilieux, ou tubulo-vilieux.

**Risque Évolutif** : Recherche systématique de dysplasie. Certaines formes sont susceptibles de donner naissance à un carcinome. [Ref: Q3]





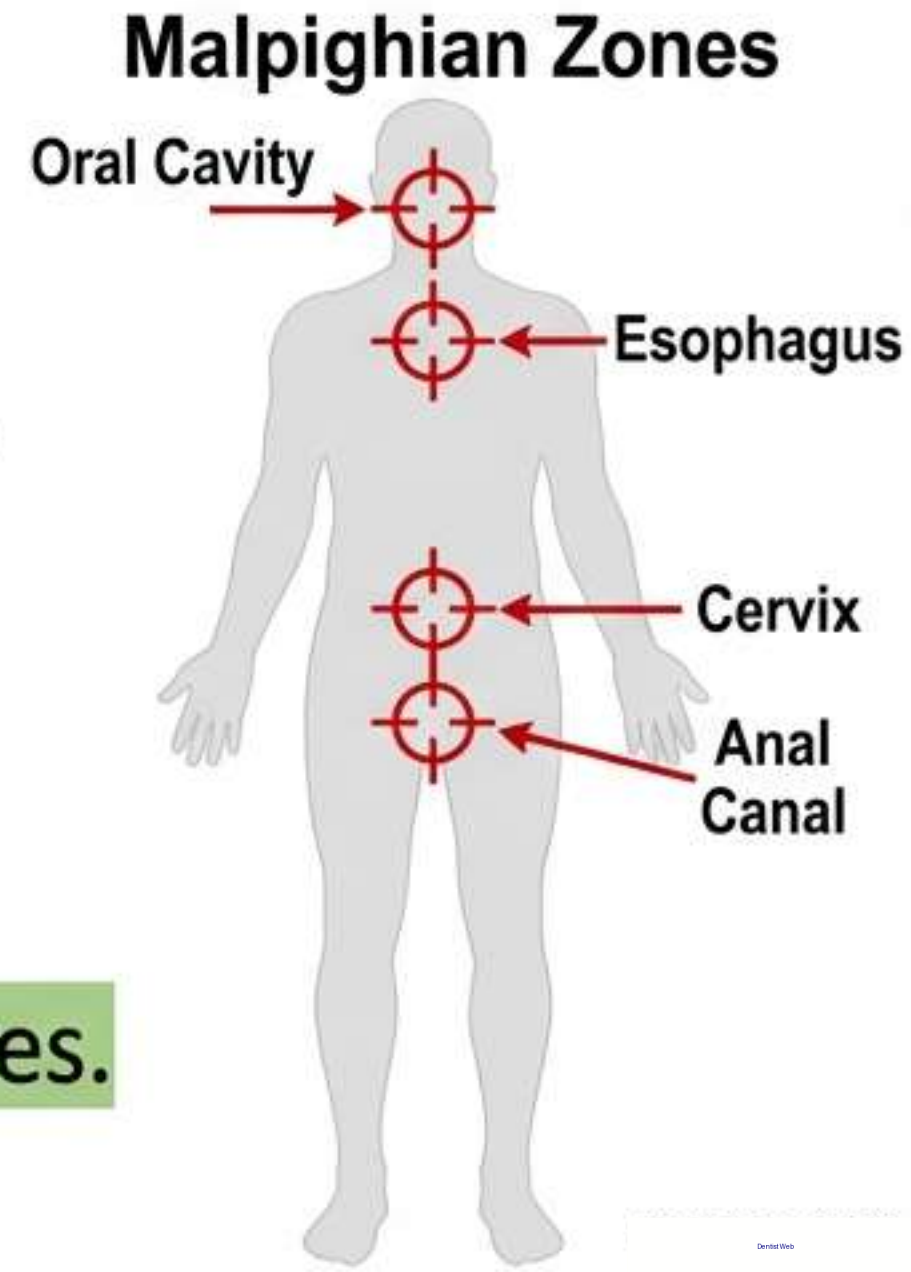
## 2. Les Carcinomes : Définitions & Généralités

**Définition Majeure** : Le terme 'Carcinome' (ou épithélioma) désigne les tumeurs malignes développées à partir de structures épithéliales : épithéliums de revêtement ou parenchymes glandulaires. [Ref: Q2, Q4]

### Carcinomes Épidermoïdes (Généralités) :

- Reproduisent la structure d'un épithélium malpighien.
- **Localisations** : Peau, Muqueuses malpighiennes digestives (Bouche, Œsophage, Canal anal), Muqueuses génitales (Exocri, Vagin, Vulve).

**Concept Clé** : Carcinomes Métaplasiques = Carcinomes épidermoïdes se développant sur des épithéliums glandulaires. [Predicted – Metaplasia mechanism]

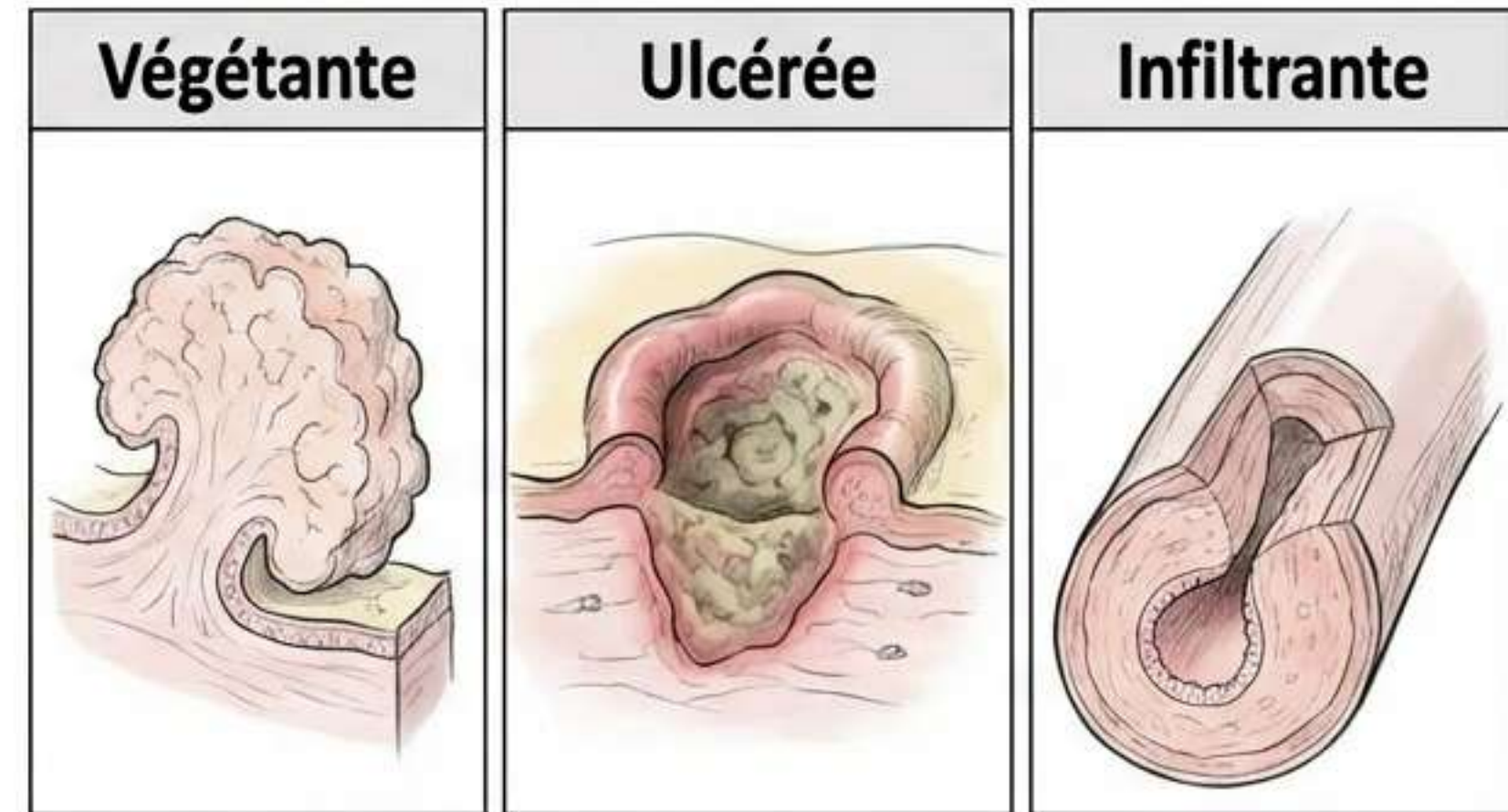




# Carcinomes Épidermoïdes : Aspects Macroscopiques

## Formes Évoluées :

1. **Végétantes (Bourgeonnantes)** : Massif tumoral faisant saillie (cutané ou lumière d'un organe).
2. **Ulcérées** : Perte de substance, fond sale. Souvent entourée par un bourrelet tumoral. [Ref: Q9]
3. **Infiltrantes** : Envahissement profond, épaissement, rigidité, sténose.



## Association :

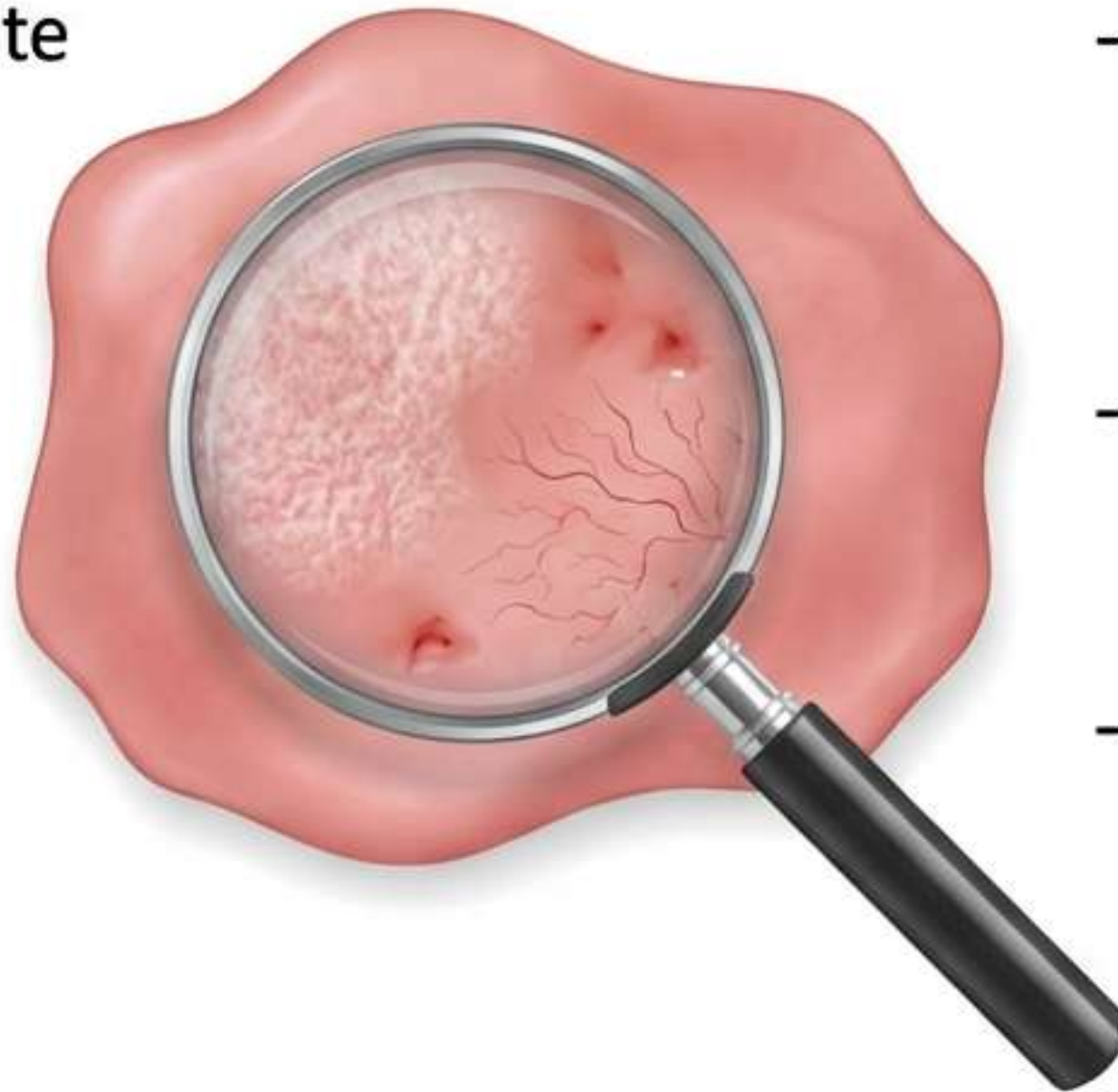
**Association** : Les formes pures sont rares. Fréquence élevée des formes **Ulcéro-Ulcéro-végétantes** ou **Ulcéro-infiltrantes**.



# Dépistage Précoce & Architecture Histologique

## Aspects de Début (Dépistage)

- Toute anomalie persistante doit inciter à la biopsie :
- Zone dépolie d'une muqueuse.
- Plage télangiectasique (vaisseaux dilatés).
- Érosion superficielle.



## Architecture Histologique Générale

- **Structure** : Lobules (massifs arrondis) et Travées.
- **Stroma** : Abondance variable, réaction inflammatoire.
- **Cellules** : Critères cytologiques de malignité (Atypies, mitoses).



# Critères de Différenciation & Maturation

## Carcinome Épidermoïde Bien Différencié :

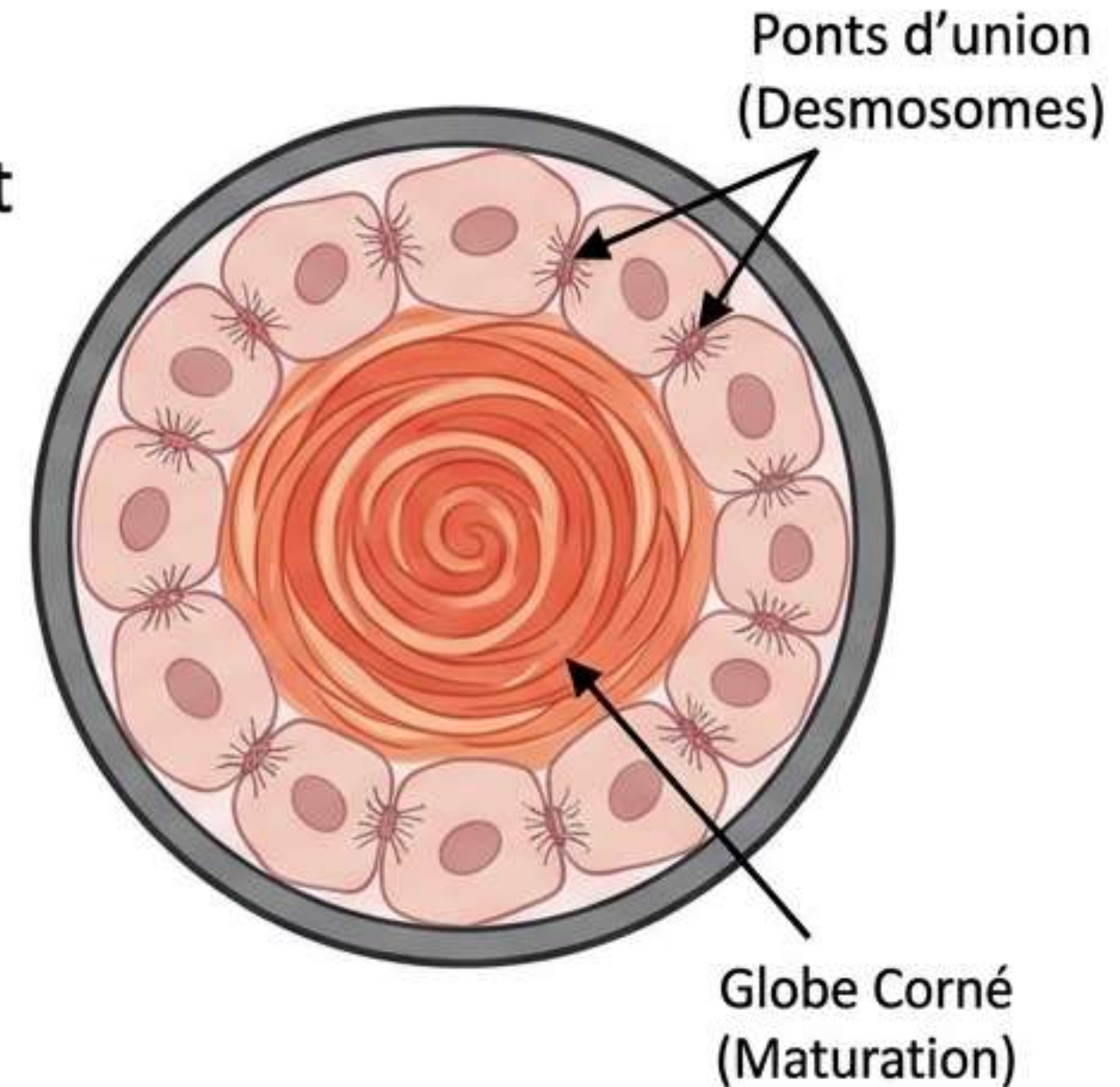
- Périphérie du lobule : Cellules cubiques/basophiles (Rappel couche basale).
- Centre du lobule : Cellules polygonales, grandes.

Marqueur Clé : Présence de 'Ponts d'union' intercellulaires (aspect corps muqueux de Malpighi). [Ref: Q6]

## Carcinome Peu Différencié :

- Cellules conservant l'aspect basal, ébauche rare de différenciation.

Maturation : Désigne le processus de Kératinisation (Ortho-, para- ou dyskératosique). [Ref: Q6]





# Cas Particulier : Les Cancers Cutanés

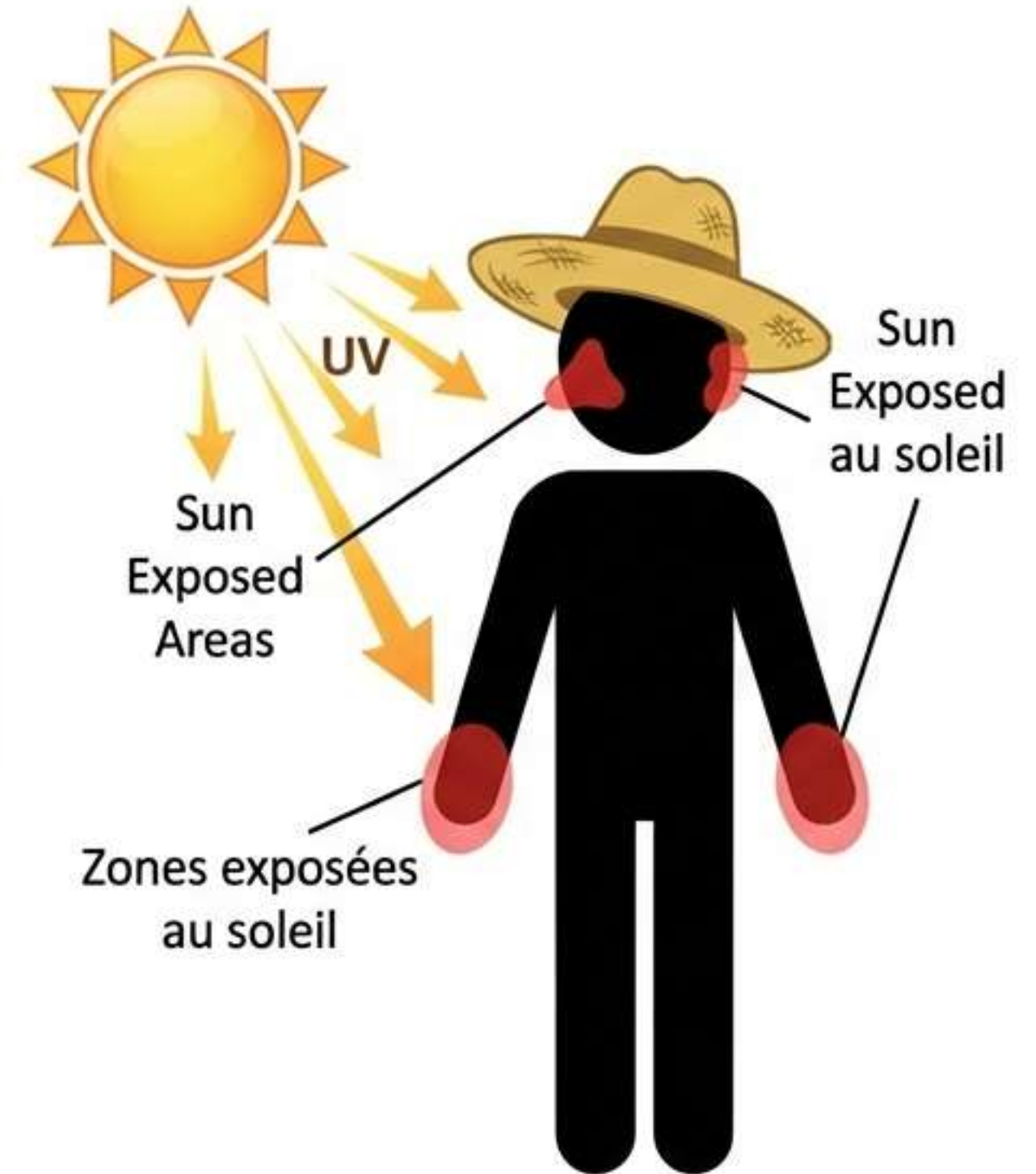
## Épidémiologie :

- Fréquents chez les sujets de race blanche.
- Zones exposées aux UV : Lèvres, Face, Tempes, Oreilles, Dos des mains.

**Professions à Risque** : Marins, Agriculteurs (Exposition solaire chronique). [Predicted – Clinical Scenario]

## Lésions Préexistantes (Précurseurs) :

- Radiodermites.
- Lésions inflammatoires chroniques.
- Xeroderma Pigmentosum.





# Carcinomes Épidermoïdes (Spinocellulaires)

## Macroscopie :

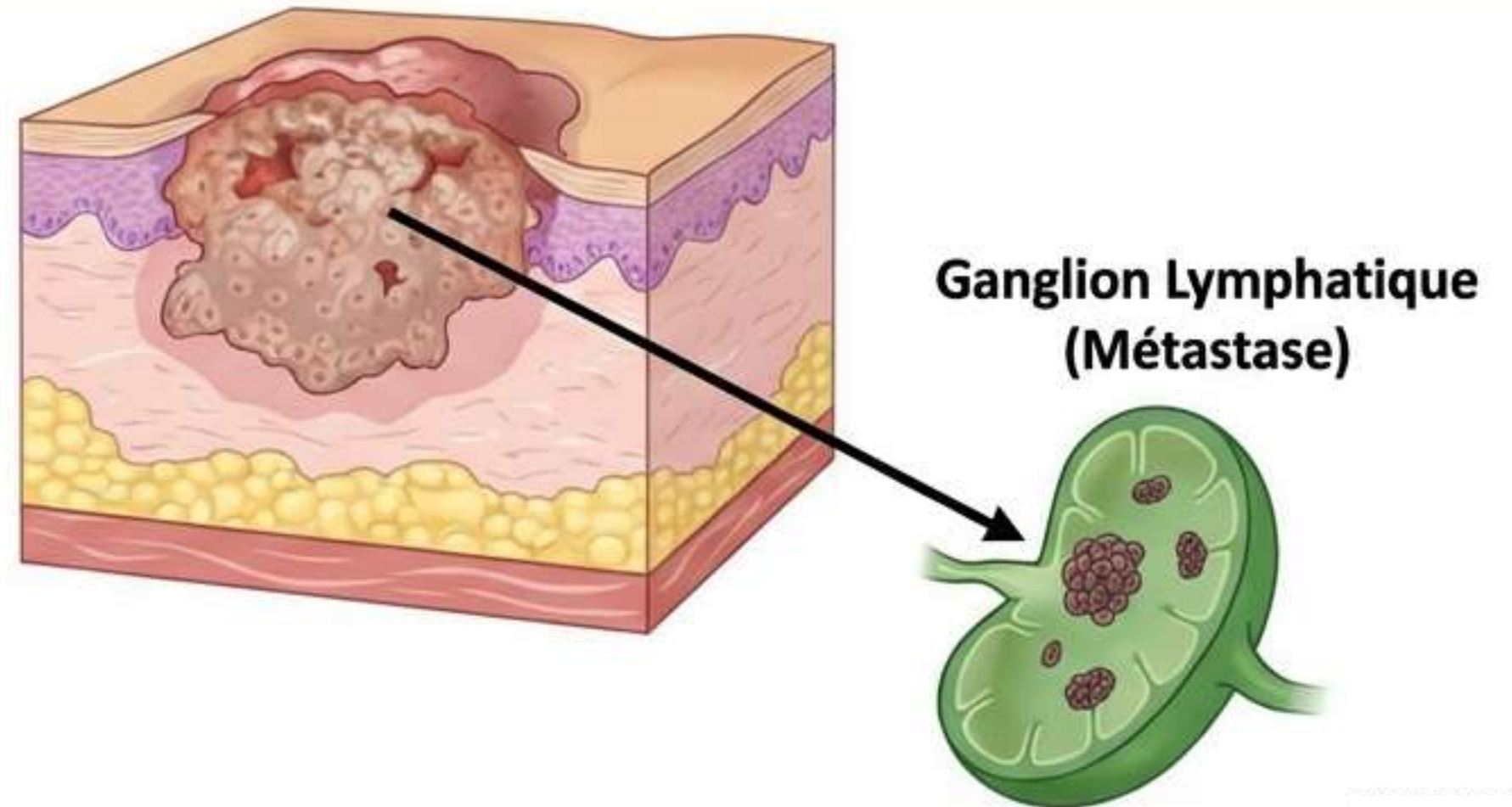
- Forme habituelle : Ulcéro-végétante.
- Forme spécifique : "Corne cutanée" (Végétante pure).

## Histologie :

- **Caricature d'épiderme** : Cellules basaloïdes en périphérie + Corps de Malpighi avec ponts d'union (épines).
- Avec ou sans globes cornés (maturation).

## Évolution (DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL) :

- Extension locale.
- Envahissement lymphatique avec **MÉTASTASES GANGLIONNAIRES**.
- (Métastases viscérales exceptionnelles). [*Predicted – Contrast with Baso*]





# Carcinomes Basocellulaires

## Macroscopie Variée :

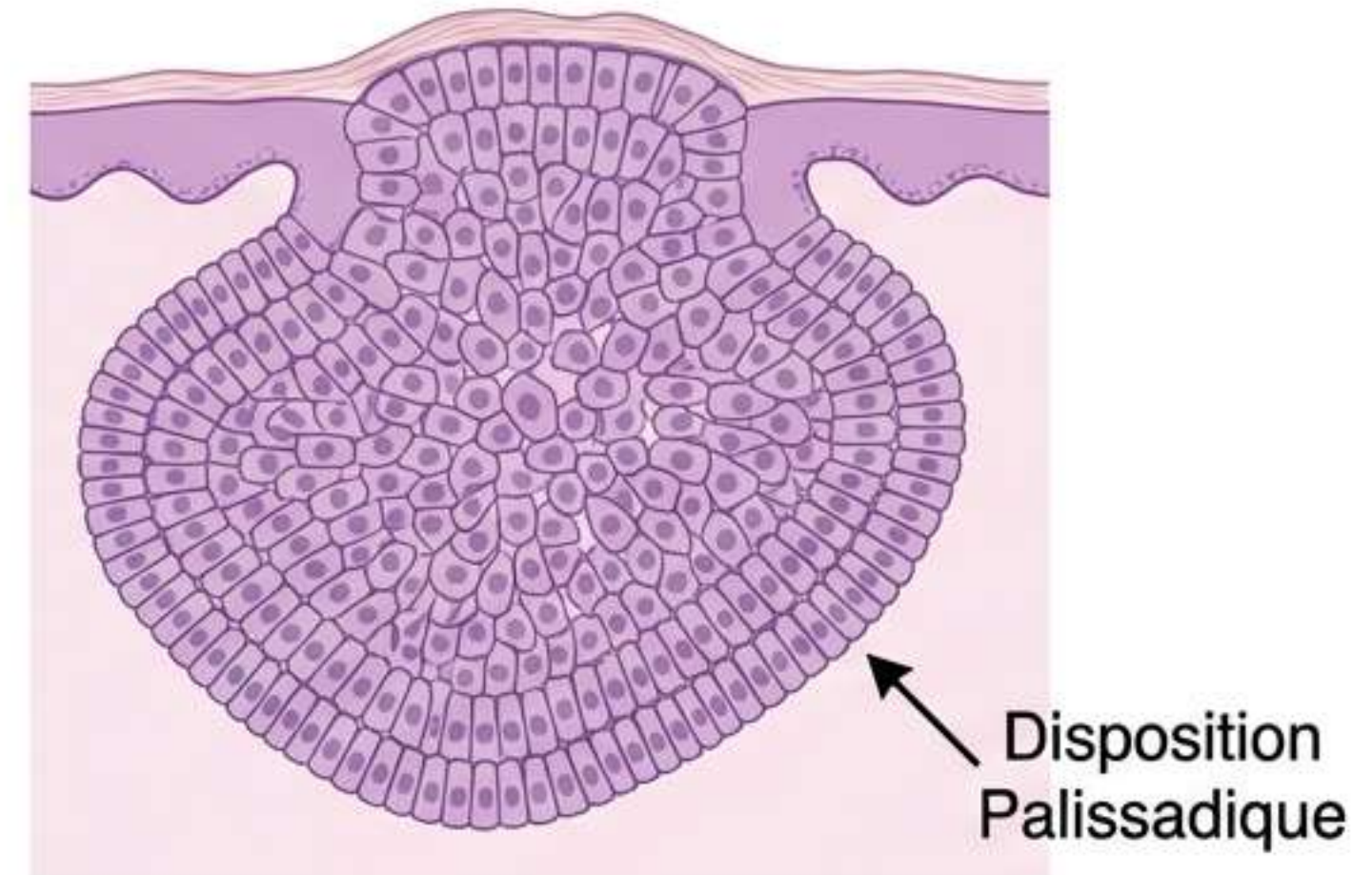
- Forme ulcérée : 'Perlé' (ulcération entourée de petites élevures).
- Forme cicatricielle ou pigmentée.

## Histopathologie :

- Lobules appendus à la face profonde de l'épiderme.
- **Architecture** : Disposition palissadique caractéristique en périphérie. [Predicted – Keyword]
- **Marqueurs Négatifs** : Ni différenciation malpighienne, ni maturation (pas de kératine).

**Évolution** : Lente, strictement locale. SANS MÉTASTASE. [Predicted – Absolute Rule]

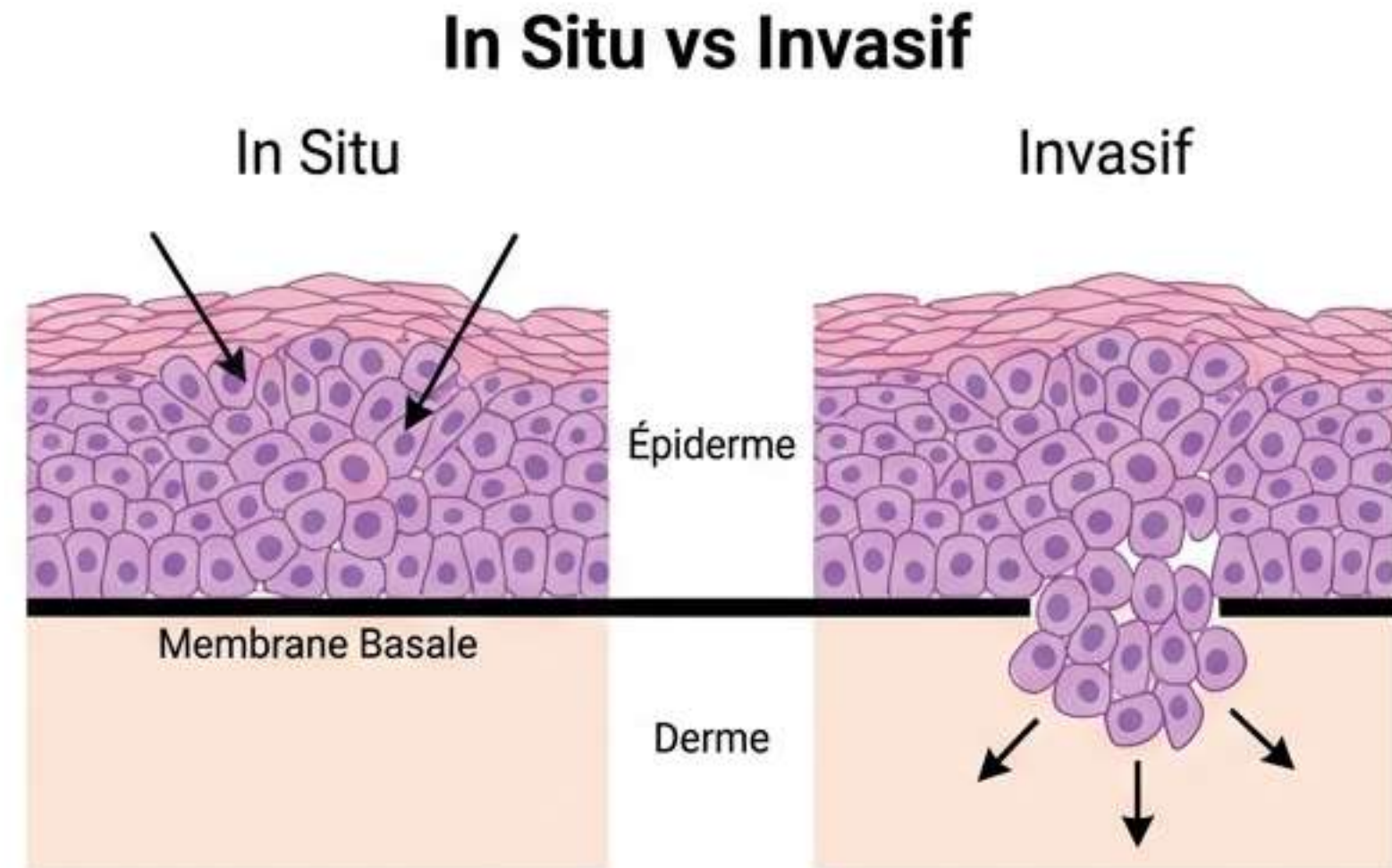
## Lobule Basocellulaire (Schéma)





# Carcinome Épidermoïde In Situ (Maladie de Bowen)

- **Définition :**
  - Modifications intra-épithéliales (désorganisation, atypies, dyskératose).
- **Critère Majeur :** Respecte la membrane basale (ne la franchit pas). [Ref: Q7]
- **Aspect Clinique :**
  - Peau : Lésions érythémateuses, bien limitées.
  - Muqueuse : Leucoplasie (tache blanche).
- **Évolution :** Risque de transformation en carcinome épidermoïde invasif.





# 3. Carcinomes des Parenchymes Glandulaires

## Généralités :

- Touchent tous les parenchymes (exocrines ou endocrines).

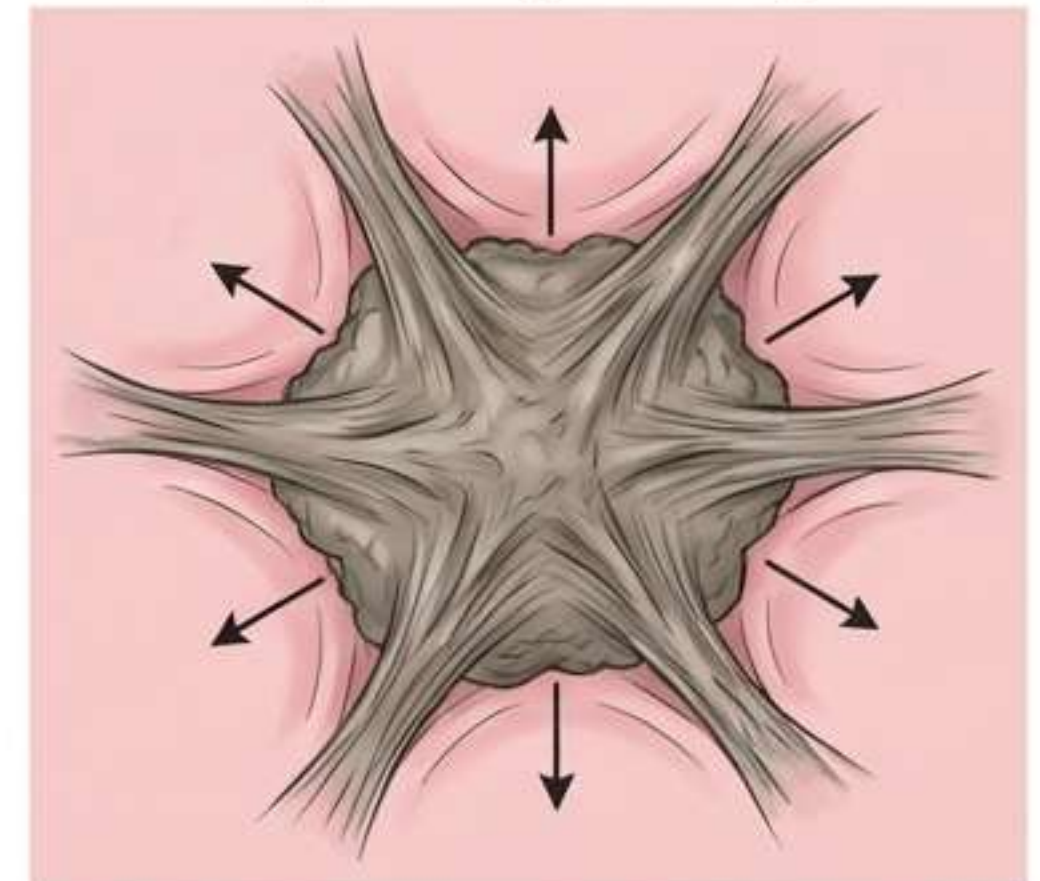
**Terminologie** : Tumeur maligne glandulaire = Adénocarcinome. [Ref: Q4]

## Macroscopie :

- Volontiers **Nodulaires**. Mal limités.
- Remaniements : Nécrose, hémorragie.

**Forme Spécifique** : Squirrhe. Dureté et caractère rétractile dus à l'abondance du stroma fibreux. [Predicted – Visual Feature]

Squirrhe (Schéma)





# Adénocarcinomes : Classification Histologique

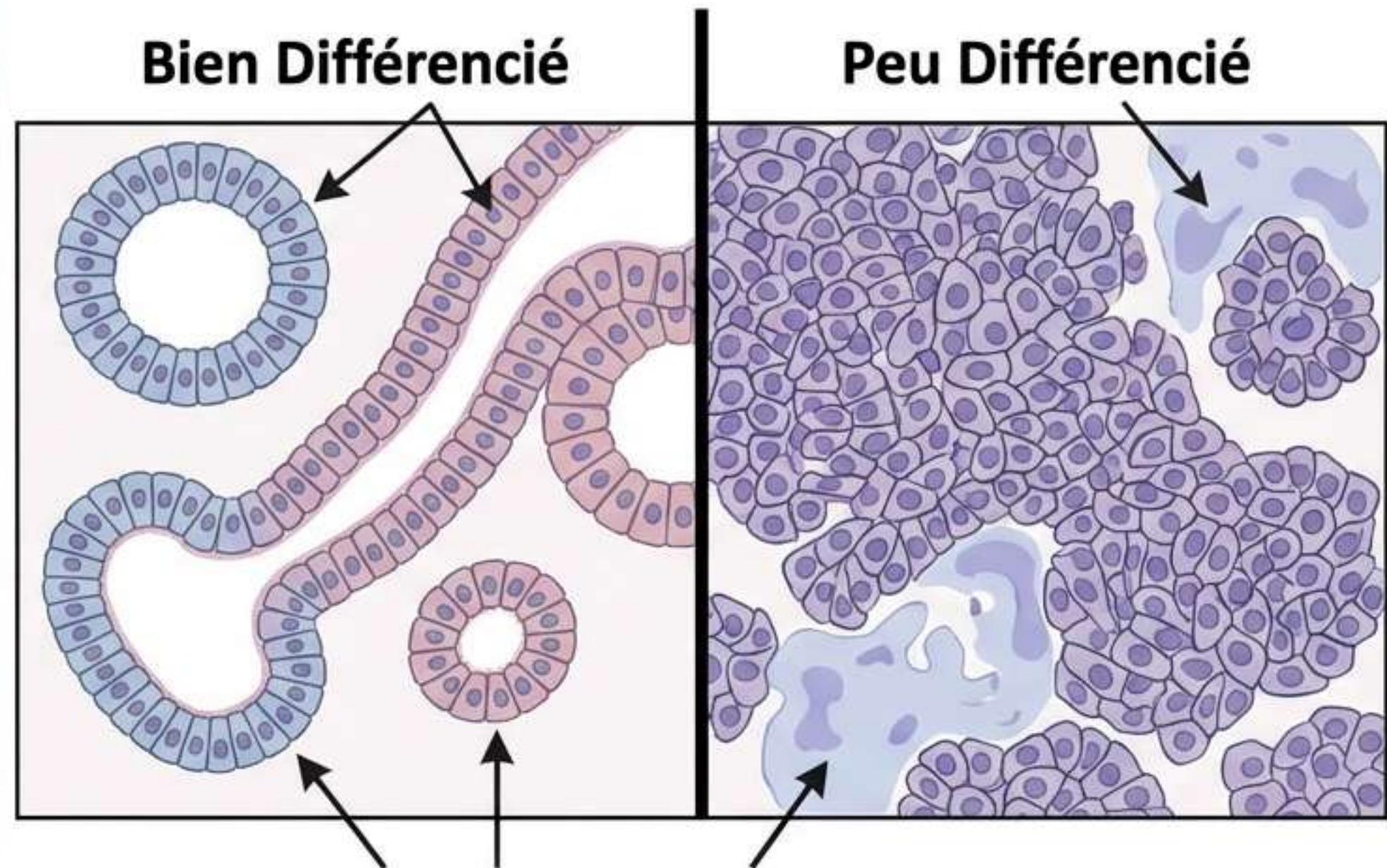
- **Critère de Classement** : La différenciation (ressemblance avec le tissu normal).

- **Bien Différenciés :**

- Groupements proches des structures normales.
- Architecture : Glandes, tubes, papilles, acini, vésicules.

- **Moyennement et Peu Différenciés :**

- Grand polymorphisme.
- Massifs polyadénoïdes ou cribriformes (aspect de crible/passoire).
- Carcinome colloïde muqueux (vastes plages de mucus).





# Formes Spécifiques & Techniques Complémentaires

- **Cellules en 'Bague à Chaton' :**

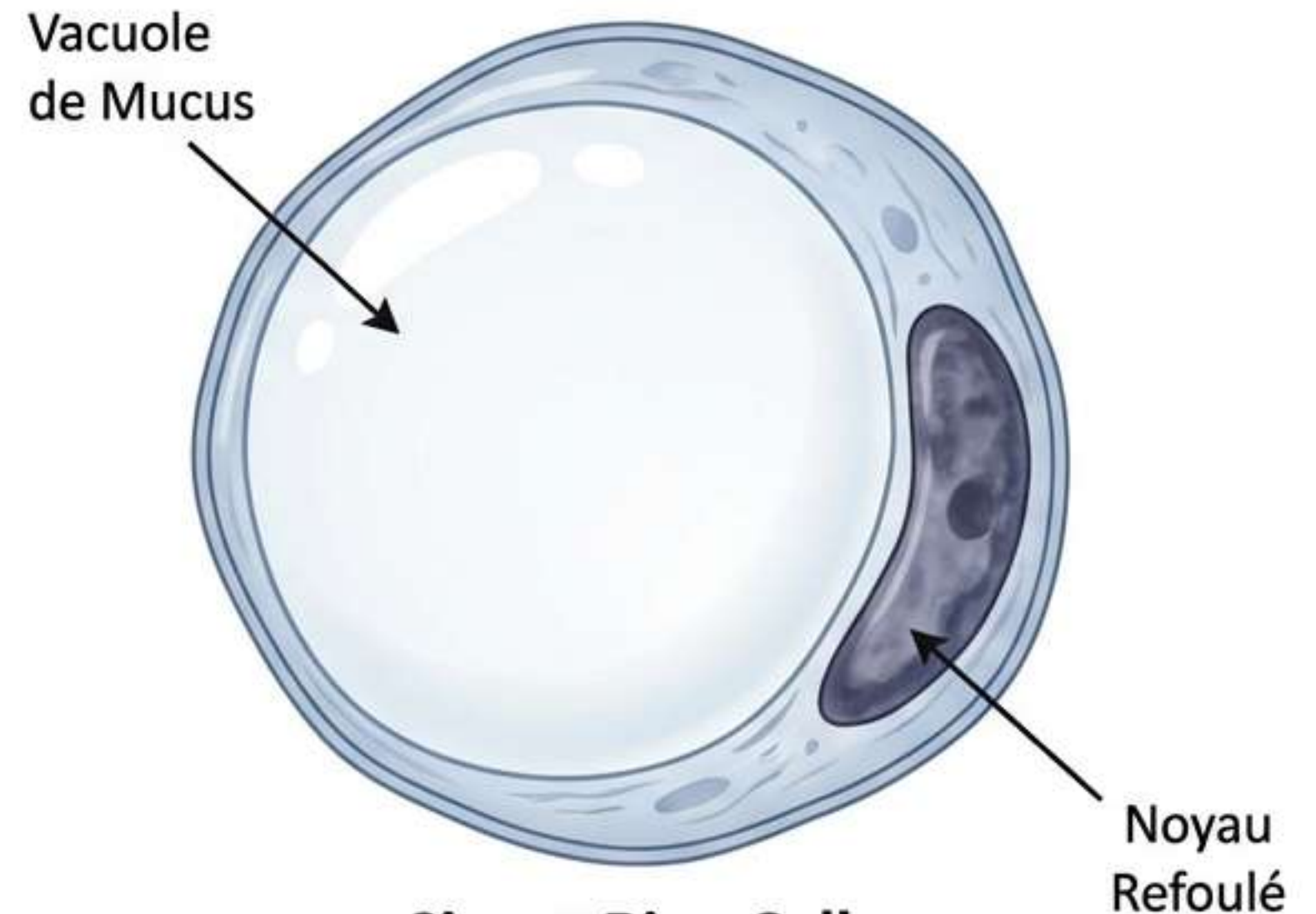
- Cytoplasme déformé par une volumineuse vacuole de mucus qui refoule le noyau en périphérie. [Predicted – Classic Image]

- **Histochimie (Preuve de Mucosécrétion) :**

- PAS, Mucicarmin, Bleu Alcian.

- **Immunohistochimie (Preuve de Nature Épithéliale) :**

- Marqueurs : EMA, KL1 (Cytokératines). [Predicted – Markers]



**Signet Ring Cell**  
(Cellule en Bague à Chaton)



# Synthèse Globale : Tumeurs Épithéliales

